Desigualdades en Hospitalizaciones Complejas

Universidad del Desarrollo

<Informática UDD/>

Ignacia Castillo, María Amalia Díaz, Maria Poddubnaya, Juan Pablo Molina, Karen Oróstica, Facultad de Ingeniería, Universidad del Desarrollo

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

En Chile existen importantes desigualdades territoriales en el **acceso a hospitalizaciones complejas**, asociadas a diferencias en infraestructura y disponibilidad de camas. Estas brechas se intensificaron durante la pandemia, afectando especialmente a comunas con menor desarrollo socioeconómico.

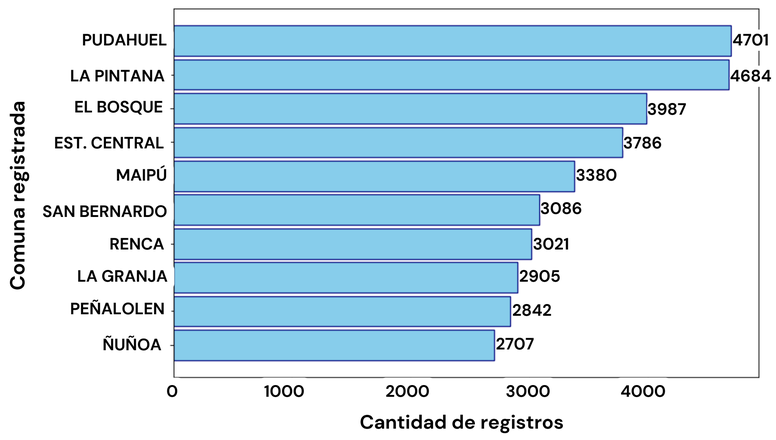
A partir de esto, surge la pregunta: **¿Cómo varía la distribución de diagnósticos en hospitalizaciones complejas según el nivel de disponibilidad hospitalaria comunal en Chile durante el periodo 2019–2024?**

El objetivo de este estudio es **aportar evidencia empírica** para orientar políticas públicas que reduzcan brechas y mejoren la asignación territorial de recursos hospitalarios.

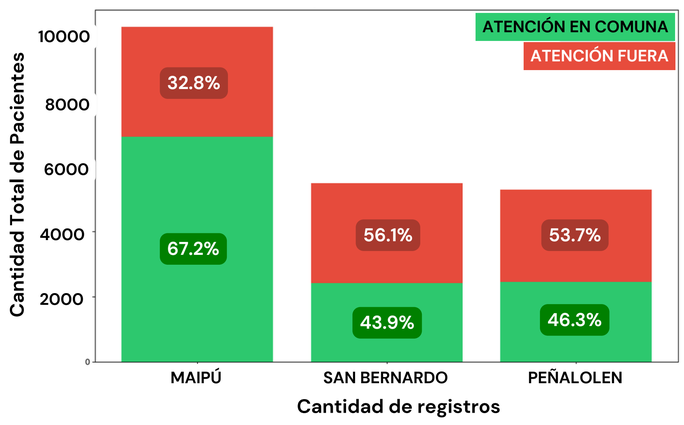
RESULTADOS

1. PACIENTES

Top 10 comunas con más pacientes atendidos fuera de su comuna

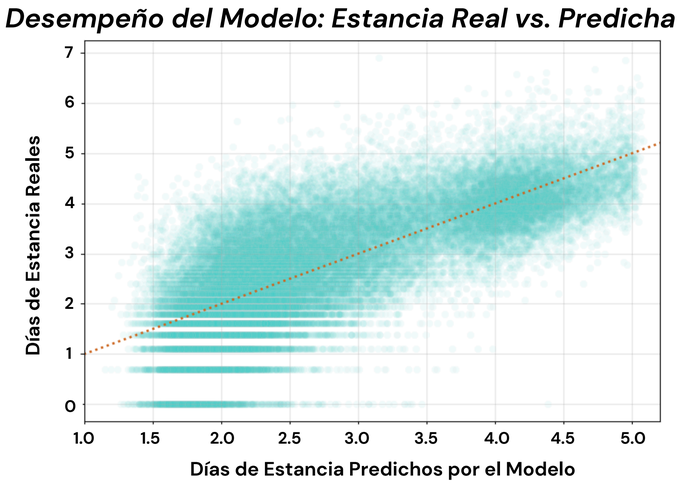


Pacientes Totales por Comuna: Distribución Local vs. Externa

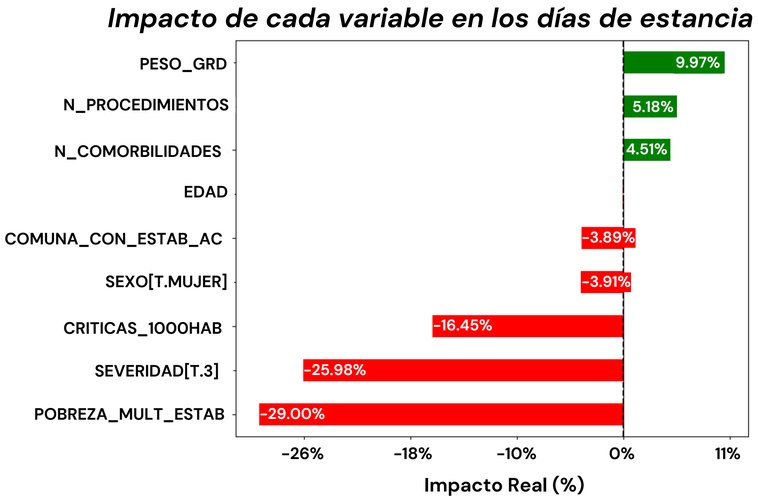


2. MODELO

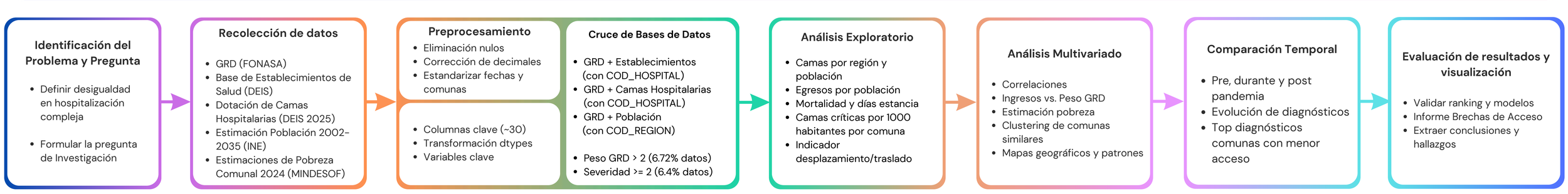
Desempeño del Modelo: Estancia Real vs. Predicha (log)



Impacto de cada variable en los días de estancia



METODOLOGÍA



DISCUSIÓN

- **Desigualdad:** Comunas como Pudahuel, La Pintana y El Bosque externalizan el 100% de sus hospitalizaciones complejas por falta de infraestructura hospitalaria compleja local.
- **Saturación:** Incluso en comunas con hospitales (Maipú, San Bernardo), la capacidad es insuficiente para cubrir la demanda interna.
- **Mortalidad:** No se halló diferencia significativa en la proporción de fallecidos según la presencia de hospitales complejos en la comuna; la mortalidad depende de factores clínicos más profundos.
- **Eficiencia:** La mayor disponibilidad de camas críticas y establecimientos complejos reduce los días de estancia.
- **Determinantes Sociales:** El índice de pobreza multidimensional afecta directamente la duración de la hospitalización, confirmando que la vulnerabilidad socioeconómica condiciona la experiencia sanitaria.

CONCLUSIONES

- Los resultados evidencian **desigualdades territoriales en el acceso a hospitalizaciones complejas**, reflejadas en desplazamientos forzados hacia comunas con mejor infraestructura y en diferencias en la estancia hospitalaria asociadas a factores clínicos y territoriales.
- Si bien estas brechas no se traducen directamente en mayor mortalidad, sí afectan la experiencia de atención, la continuidad del cuidado y la carga sobre ciertos servicios hospitalarios.
- El estudio **reafirma la necesidad** de fortalecer la infraestructura hospitalaria en comunas vulnerables y de incluir criterios territoriales en la planificación de recursos sanitarios.

Recomendación de Política Pública
Incorporar indicadores de desplazamiento y cobertura comunal en la asignación de recursos del FONASA y en la planificación del MINSAL.

BIBLIOGRAFÍA

- Marmot, M. (2005). Social determinants of health inequalities.
- Bambra, C., Riordan, R., Ford, J., & Matthews, F. (2020). The COVID-19 pandemic and health inequalities.
- Vásquez, F., & Paraje, G. (2017). Universal health coverage in Chile: The health system under scrutiny https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/07/PRESENTACION-APEC-GAR-25-de-julio-2017.pdf
- S Torres, J. P., et al. (2021).Impact of COVID-19 on hospital bed occupancy: A territorial analysis in Chile. Torres, J. P., et al. (2021). Impact of COVID-19 on hospital bed occupancy: A territorial analysis in Chile.

AGRADECIMIENTOS

A la profesora Karen Oróstica, al ayudante David Hernández, y a la escuela de Informática de la Universidad del Desarrollo por el apoyo prestado. Agradecimiento especial a las instituciones FONASA, DEIS, INE y MINDESOF por el acceso a datos públicos.